

ANIMAL PEÇONHENTO — PEDIATRIA

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

PEÇONHENTO — IDENTIFICAR SÍNDROME + SORO

Acidente peçonhento na criança (mais grave: veneno/kg)
ABCDE + identificar o animal/síndrome

Classificar gravidade + hidratação + analgesia

SORO ANTIPEÇONHENTO específico
(não atrasar; adrenalina à beira-leito)

Notificação compulsória (SINAN)

PRINCÍPIOS GERAIS

POR QUE É MAIS GRAVE NA CRIANÇA

- Relação VENENO/MASSA CORPORAL maior -> concentrações séricas de toxina mais altas e rápidas
- Priorizar ABCDE (choque anafilático/neurogênico pode ocorrer); 2 acessos calibrosos
- Evitar acesso jugular/subclávia se coagulopatia (risco de hematoma compressivo)
- Identificar o animal (foto se possível), mas NUNCA tentar capturá-lo
- Notificação COMPULSÓRIA (SINAN); profilaxia antitetânica (ferimento com porta de entrada)

O QUE NÃO FAZER

ORIENTAR PAIS / APH

- NÃO fazer torniquete/garrote (necrose; não impede a absorção)
- NÃO cortar, furar ou sugar o local da picada
- NÃO aplicar substâncias (pó de café, fumo, álcool) nem gelo
- NÃO oferecer álcool nem sedativos à criança
- Não atrasar o soro para fazer pré-medicação; ter ADRENALINA preparada à beira-leito

ESCORPIONISMO — O GRANDE VILÃO URBANO

VÔMITOS = GRAVIDADE

- *Tityus serrulatus* (amarelo) é a principal causa de envenenamento em crianças no Brasil
- Dor local imediata e intensa, mas a GRAVIDADE é sistêmica (estimulação autonômica)
- SINAL DE ALERTA: VÔMITOS INCOERCÍVEIS = risco de edema agudo de pulmão e choque
- Soro antiescorpiônico (SAEsc) nos casos moderados/graves; suporte intensivo
- Monitorização cardíaca contínua; preparar via aérea/aspiração (sialorreia/vômitos)

OFIDISMO — SÍNDROME DEFINE O SORO

Acidente	Clínica	Soro (level/mod -> grave)
Botrópico (jararaca, ~90%)	Dor/edema progressivo, equimose, bolhas, sangramento; IRA/sd. compartimental	SAB: 2-4 / 4-8 / 12 ampolas
Crotálico (cascavel)	Fácies miastênica, mialgia, urina escura (mioglobínúria); alto risco de IRA	SAC: 5-10 / 20 ampolas
Laquético (surucucu)	Edema grave + efeito vagal (cólica, diarreia, bradicardia, hipotensão)	SAL/SABL: 10-20 ampolas
Elapídico (coral)	Neurotóxico puro: ptose, oftalmoplegia, disfagia -> paralisia respiratória	SAE: 10 ampolas + preparar IOT

ARANEÍSMO E LAGARTAS

Agente	Clínica	Conduta
Loxosceles (marrom)	Picada indolor; placa marmórea/necrose 12-24h; forma cutâneo-visceral: HEMÓLISE/IRA	SALox 5-10 amp se hemólise/lesão grave; prednisona (controverso)
Phoneutria (armadeira)	Dor local intensa; criança: choque neurogênico, EAP, priapismo	Bloqueio anestésico local; SAAr 2-4 amp se mod/grave
Latrodectus (viúva-negra)	Dor muscular, contraturas, 'abdome em tábua', tremores	Benzodiazepínico + gluconato de cálcio; soro em casos graves
Lonomia (taturana)	Queimação local + síndrome HEMORRÁGICA (TAP/TTPA altos, fibrinogênio baixo)	SALon 5 / 10 ampolas

MANEJO GERAL PEDIÁTRICO

PILARES

- HIDRATAÇÃO VIGOROSA (manutenção dobrada nas primeiras horas) para prevenir NTA por mio/hemoglobinúria (crotálico, loxoscélico)
- Analgesia (dipirona; bloqueio local com lidocaína sem vaso no foneutrismo)
- Profilaxia antitetânica conforme status vacinal
- ATB NÃO de rotina (só se necrose extensa/infecção ou chegada tardia com sinais flogísticos)
- Soro é específico por síndrome e por gravidade — calcular pelo número de ampolas (não pelo peso)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Criança ____ anos/____ kg; acidente por ____ (escorpião/jararaca/cascavel/coral/aranha/lonomia); local ____; tempo ____.
- Manifestações: locais ____ / sistêmicas ____ (vômitos? sangramento? fácies miastênica?); gravidade: leve/moderada/grave.
- Soro ____ (tipo, ____ ampolas) iniciado às ____; hidratação ____; antitetânica.
- Solicito UTI pediátrica + monitorização; notificar SINAN. Não fazer torniquete/incisão.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o principal marcador de gravidade no escorpionismo pediátrico?

- A) Dor local intensa
- B) Vômitos incoercíveis (risco de edema agudo de pulmão e choque)
- C) Eritema no local
- D) Febre baixa
- E) Prurido

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual conduta NÃO deve ser realizada em acidente peçonhento?

- A) Hidratação venosa
- B) Torniquete/garrote e incisão/sucção do local
- C) Analgesia
- D) Soro antipeçonhento específico
- E) Profilaxia antitetânica

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Acidente ofídico com fácies miastênica (ptose), mialgia e urina escura, com pouca reação local. Qual o tipo e o risco principal?

- A) Botrópico — síndrome compartimental
- B) Crotálico (cascavel) — insuficiência renal aguda por rabdomiólise/mioglobinúria
- C) Elapídico — necrose local
- D) Laquético — hemorragia local
- E) Loxoscélico — necrose cutânea

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual medida é mandatória para prevenir a insuficiência renal nos acidentes crotálico e loxoscélico?

- A) Restrição hídrica
- B) Hidratação venosa vigorosa
- C) Diurético de rotina
- D) Antibiótico profilático
- E) Corticoide em altas doses

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

O acidente loxoscélico (aranha-marrom) na forma cutâneo-visceral, mais comum em crianças, cursa com:

- A) Paralisia respiratória
- B) Hemólise intravascular (anemia, icterícia, hemoglobinúria) e insuficiência renal
- C) Apenas necrose local
- D) Síndrome hemorrágica por consumo de fibrinogênio
- E) Bradicardia e diarreia

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

No escorpionismo pediátrico, os vômitos incoercíveis são o principal marcador de gravidade sistêmica, anunciando risco de edema agudo de pulmão e choque — indicam soroterapia e suporte intensivo.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

NÃO se faz torniquete/garrote nem incisão/sucção (aumentam necrose e não impedem a absorção). O manejo correto é ABCDE, hidratação, analgesia e soro específico, com notificação e antitetânica.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Fácies miastênica + mialgia + urina escura com pouca reação local é o acidente crotálico (cascavel), cujo principal risco é a insuficiência renal aguda por rabdomiólise/mioglobulinúria — exige hidratação vigorosa.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A hidratação venosa vigorosa é mandatória nos acidentes crotálico e loxoscélico para prevenir a necrose tubular aguda por mioglobulinúria/hemoglobulinúria.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A forma cutâneo-visceral do loxoscelismo (mais comum em crianças) cursa com hemólise intravascular (anemia, icterícia, hemoglobulinúria) e insuficiência renal aguda, além da lesão cutânea.

SM24
Suporte ao Plantão Médico